

ΟΞΕΙΑ ΜΕΣΗ ΠΥΩΔΗΣ ΩΤΙΤΙΔΑ

Γενικά: Η επίπτωση και ο επιπολασμός της οξείας μέσης πυώδους ωτίτιδας (ΟΜΠΩ) είναι σε μέγιστες τιμές στην προσχολική ηλικία και μειώνονται με την αύξηση της ηλικίας. Η μεγαλύτερη επίπτωση εμφανίζεται σε ηλικία 6-24 μηνών. Συνήθης υπεύθυνα μικρόβια είναι: ο *Streptococcus pneumoniae* (25-50%), ο *Haemophilus influenzae* (15-30%) και η *Moraxella catarrhalis* (3-20%). Από τους ιούς, συχνότερα αίτια είναι: ο RSV, corona-ιοί, ιοί της γρίπης, ανθρώπινος μεταπνευμονοϊός (h-MPV), αδενοϊοί (τύποι: 1, 2, 5, 6), κ.ά. Στη **χρόνια μορφή** της νόσου, συνήθης υπεύθυνα παθογόνα είναι ο *Staphylococcus aureus*, η *Pseudomonas aeruginosa* και τα **αναερόβια μικρόβια**. Επί παροξύνσεως χρόνιας μέσης πυώδους ωτίτιδος με ρήξη του τυμπάνου, η αντιβιοτική θεραπεία πρέπει να κατευθύνεται μόνον από τα αποτελέσματα των καλλιεργειών πύου και το συνοδό αντιβιογράμμα.

Ιστορικό: Ελέγχουμε αν πρόκειται για μεμονωμένο επεισόδιο ΟΜΠΩ ή υπάρχει υποτροπή. Ελέγχουμε για συννοσηρότητα (ΣΔ, ανοσοκαταστολή, φορία-HIV, ασπληνία, κ.ά.). Διερεύνηση υποκειμένου νοσήματος ή άλλων αιτιολογικών παραγόντων. Εάν συνυπάρχει ΣΔ απαιτείται διαφορική διάγνωση από την «**κακοήγη εξωτερική ωτίτιδα**» το αίτιο της οποίας είναι η *Pseudomonas aeruginosa*. Σε αυτή την περίπτωση η διάγνωση της νόσου επιβεβαιώνεται ωτοσκοπικά (*παρουσία τυπικών σαρκίων στην οστεοχονδρική συνένωση*).

Κλινική εξέταση: Ο ασθενής με ΟΜΠΩ παρουσιάζεται στο ιατρείο με έντονη ωταλγία, με ή χωρίς πυρετό. Στην ωτοσκόπηση η τυμπανική μεμβράνη προβάλλει και είναι εξέρυθρη. Παρατηρείται υδραερικό επίπεδο πίσω από αυτή. Περιστασιακά, σε περιπτώσεις ρήξης της τυμπανικής μεμβράνης, μπορεί να εμφανιστεί αιφνίδια απώλεια της ακοής και ωτόρροια. Η παρουσία χολοστεατώματος επιβάλλει ΩΡΛ-χειρουργική εκτίμηση και αντιμετώπιση.

Θεραπευτική παρέμβαση

Επί ΟΜΠΩ απαιτείται αντιβιοτική θεραπεία διάρκειας 7-10 ημερών (*εξαίρεση αποτελεί η Αζιθρομυκίνη η οποία χορηγείται επί 6 ημέρες*). Έτσι, μπορεί να χορηγηθούν τα κάτωθι:

1. **Αμοξυκιλλίνη:** tab. *Amoxil* 1 g, 1x2 (po), για 7-10 ημέρες, ή επί ενδείξεων **Αμοξυκιλλίνη/Κλαβουλανικό:** tab. *Augmentin* 1 g, 1x2 (po), για 7-10 ημέρες, * (*Δοσολογία Αμοξυκιλλίνης στα παιδιά: 15-30 mg/kg ΒΣ ανά 8ωρο, για 10 ημέρες, per os*).
2. Εναλλακτικά, αντί των πενικιλλινών, μπορεί να χορηγηθούν τα κάτωθι αντιβιοτικά:
Κεφπροζίλη: tab. *Procef/Pricefil* 500 mg, 1x2 (po), για 7-10 ημέρες ή
Κεφακλόρη: tab. *Ceclor MR* 750 mg, 1x2 (po), για 7-10 ημέρες ή
Κεφατριζίνη: caps. *Cefatrizine/Cettrizin* 500 mg, 1x2 (po), για 7-10 ημέρες, * [*Δοσολογία Κεφατριζίνης (syr. 250 mg/5 ml), σε παιδιά: 10-20 mg/kg/12ωρο, για 10 ημέρες, po*].
3. **Κλαριθρομυκίνη:** tab. *Klaricid/Macladin* 500 mg, 1x2 (po), για 10 ημέρες, ή **Αζιθρομυκίνη:** tab. *Zithromax/Zinfect* 500 mg / 24h (po), για 6 ημέρες.
Τονίζεται το αυξημένο ποσοστό αντοχής ($R > 30\%$) του Πνευμονιοκόκκου έναντι των Μακρολιδών, στον ελληνικό πληθυσμό, ένεκα της μακροχρόνιας και συνεχιζόμενης κατάχρησης αντιβιοτικών!
4. Η χορήγηση προχωρημένων αντιβιοτικών, όπως των νεότερων Κινολονών (*που ουδέποτε χορηγούνται σε παιδιά*) ή Κεφαλοσπορινών 3^{ης} γενεάς (π.χ. Κεφιξίμη/*Ceftoral* 400 mg), προϋποθέτει την απομόνωση του παθογόνου αιτίου με καλλιέργειες και αντιβιογράμμα το οποίο να αποδεικνύει ότι τα προειρημένα αντιμικροβιακά πλεονεκτούν in vitro.
5. **Αποσυμφορητικά**, τοπικά ρινικά, έως 5 ημέρες, εφόσον συνυπάρχει ρινική συμφόρηση. Nasal spray *Dexarhina* ή *Dymista*, 2 ψεκασμοί/ρόθωνα, κάθε 6-8 ώρες, για 3-5 ημέρες. (*Προσοχή: εφόσον δοθεί Αζιθρομυκίνη αποφεύγουμε τη συγχορήγηση αντιισταμινικών*).
6. Η αντιβιοτική κάλυψη θα πρέπει να παρατείνεται για 21 ημέρες σε ασθενείς με ΟΜΠΩ και συνοδό ωτόρροια, ενώ για την έντονη ή επίμονη ωταλγία θα πρέπει να χορηγείται η ανάλογη αναλγησία (*Depon, Ponstan, Mesulid, Voltaren, Xefo, Viaxal, Lonarid, κ.ά.*).
7. Ασθενείς με πάνω από 4 επεισόδια ανά έτος θεωρούνται υποψήφιοι για μυριγκοτομή.